

CAPÍTULO 13.51

Respirador Bucal

PERFIL EUNACOM 1.13.51

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El síndrome del **respirador bucal** es una condición frecuente en la práctica clínica, especialmente en niños. Se define por la sustitución del patrón de respiración nasal fisiológico por un patrón de respiración oral. Su importancia radica en que la nariz cumple funciones críticas de filtrado, humidificación y calentamiento del aire, además de que la respiración bucal crónica puede alterar el desarrollo maxilofacial.

Clasificación de los Respiradores Bucleas

Es fundamental distinguir entre quienes realmente tienen una patología y quienes mantienen la boca abierta por otros motivos.

TABLA 13.51.1: TIPO DE RESPIRADOR VS DESCRIPCIÓN

TIPO DE RESPIRADOR	DESCRIPCIÓN
Falsos Respiradores	Pacientes que mantienen la boca abierta (frecuentemente por hábito o debilidad muscular), pero el flujo de aire sigue siendo predominantemente nasal .
Verdaderos Respiradores	El flujo de aire ingresa efectivamente por la cavidad oral. Se divide en obstructivos y no obstructivos.

Subtipos de Verdaderos Respiradores

- **Obstructivos:** Existe un impedimento físico que impide el paso del aire por la nariz o rinofaringe. El paciente **está obligado** a respirar por la boca.
- **No Obstructivos:** No existe una barrera física. Si se le pide al paciente que cierre la boca, puede respirar por la nariz sin dificultad. Generalmente se asocia a:
 - **Hiperlaxitud:** Niños con tono muscular disminuido que mantienen la mandíbula caída.
 - **Mal hábito:** Persistencia de la respiración oral tras haber solucionado una causa obstructiva previa.

Etiología (Causas)

Las causas varían según el tipo de respirador y la edad del paciente:

- **Obstructivas (Más frecuentes):**
 - **Hipertrofia de Adenoides:** La causa más común de obstrucción persistente en niños.
 - **Rinitis Alérgica:** Causa inflamación de la mucosa nasal y aumento de resistencia al flujo.
 - **Tumores Nasosinuales:** Menos frecuentes, pero deben sospecharse ante obstrucción unilateral o progresiva.
 - **Desviación del Tabique Nasal:** Obstrucción mecánica anatómica.
- **No Obstructivas:**
 - Mal hábito postural.
 - Hiperlaxitud ligamentosa/muscular.

NOTA CLÍNICA

La respiración bucal crónica en niños puede llevar a la "facies adenoidea": cara alargada, ojeras, boca entreabierta, paladar ojival (estrecho y alto) y maloclusión dental.

Diagnóstico y Estudio

El estudio está orientado a identificar si existe una obstrucción mecánica y dónde se localiza.

- **Examen Físico:** Observar si el paciente puede mantener la boca cerrada por 1-2 minutos sin angustia respiratoria. Evaluar la presencia de rinitis (mucosa pálida, rinorrea).
- **Radiografía de Cavum Rinofaríngeo:** Es el examen de elección inicial para evaluar el tamaño de las adenoides y el grado de obstrucción del espacio aéreo nasofaríngeo.

- **Nasofibroscopia:** Permite una visualización directa de toda la vía aérea superior (fosas nasales, coanas y rinofaringe). Es el estándar de oro para ver tumores o malformaciones.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el examen EUNACOM, ante un niño con ronquido nocturno y respiración bucal constante, la **Radiografía de Cavum** suele ser la respuesta correcta para confirmar **Hipertrofia de Adenoides**.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento es estrictamente etiológico (según la causa detectada):

- **Hipertrofia de Adenoides:** Si existe clínica obstructiva importante y se confirma por radiografía, el tratamiento es la **adenoidectomía** (cirugía).
- **Rinitis Alérgica:**
 - El tratamiento de elección para la obstrucción nasal son los **corticoides intranasales**.
 - Los antihistamínicos son útiles para el prurito y la rinorrea, pero tienen poco efecto sobre la obstrucción mecánica por inflamación.
- **Mal Hábito:** Requiere reeducación, muchas veces apoyada por fonoaudiología para fortalecer la musculatura perioral.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente presenta **Rinitis Alérgica e Hipertrofia de Adenoides** simultáneamente, siempre se debe tratar primero la rinitis con corticoides nasales. Si la obstrucción persiste tras el manejo médico, se plantea la cirugía.

Casos Especiales: El Recién Nacido

Si un recién nacido presenta respiración bucal desde el nacimiento, esto es una **emergencia o urgencia médica**, ya que los lactantes son respiradores nasales obligatorios.

- **Sospecha: Atresia de Coanas** (falta de perforación de la comunicación entre la nariz y la faringe).
- **Diagnóstico:** Se sospecha si no pasa una sonda de aspiración por las fosas nasales. Se confirma mediante **Nasofibroscopia** o TAC.
- **Tratamiento:** Quirúrgico para permeabilizar la vía aérea.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **Atresia de Coanas** bilateral se presenta como un recién nacido que tiene cianosis que **mejora con el llanto** (porque al llorar abre la boca y respira) y empeora al alimentarse.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 7 años es traído por sus padres porque siempre respira con la boca abierta. Al examen, cuando se le pide cerrar la boca, logra respirar por la nariz sin dificultad. No tiene rinorrea ni obstrucción nasal. ¿Cuál es la clasificación más adecuada de este paciente?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Respirador Bucal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Falso respirador bucal: boca abierta pero respira por la nariz. Se diferencia verificando por dónde pasa el flujo de aire.
- Verdadero respirador bucal obstructivo: no puede respirar por la nariz (nariz tapada). No obstructivo: puede pero no lo hace (hábito/hiperlaxitud).
- Causa más frecuente de respiración bucal obstructiva: rinitis alérgica (más frecuente que hipertrofia de adenoides).
- Estudio: radiografía de cavum para evaluar hipertrofia de adenoides.
- Rinitis alérgica con obstrucción → corticoides nasales. Sin obstrucción → antihistamínicos.
- Si coexisten rinitis alérgica + hipertrofia de adenoides → tratar PRIMERO la rinitis alérgica (menos invasivo).
- Recién nacido con respiración bucal desde el nacimiento → descartar atresia de coanas con nasofibroscopia.
- Atresia de coanas: malformación congénita frecuente, se diagnostica con nasofibroscopia y se opera.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RESPIRADOR BUCAL)**PREGUNTA 1**

Niño de 7 años es traído por sus padres porque siempre respira con la boca abierta. Al examen, cuando se le pide cerrar la boca, logra respirar por la nariz sin dificultad. No tiene rinorrea ni obstrucción nasal. ¿Cuál es la clasificación más adecuada de este paciente?

- A)** Falso respirador bucal
- B)** Verdadero respirador bucal obstructivo por hipertrofia de adenoides
- C)** Verdadero respirador bucal obstructivo por rinitis alérgica
- D)** Verdadero respirador bucal no obstructivo
- E)** Respirador bucal secundario a atresia de coanas

PREGUNTA 2

Niño de 4 años con obstrucción nasal persistente, rinorrea acuosa, estornudos frecuentes y respiración bucal. La radiografía de cavum muestra adenoides grado 2. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A)** Adenoidectomía, ya que tiene hipertrofia de adenoides objetivada con síntomas
- B)** Antihistamínicos orales como loratadina
- C)** Corticoides nasales y reevaluar respuesta
- D)** Antibióticos por sospecha de adenoiditis
- E)** Nasofibroscopia para descartar atresia de coanas

PREGUNTA 3

Recién nacido que presenta dificultad respiratoria al cerrar la boca durante la alimentación y cianosis que mejora con el llanto (al abrir la boca). ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el estudio inicial?

- A)** Hipertrofia de adenoides; radiografía de cavum
- B)** Rinitis alérgica neonatal; corticoides nasales
- C)** Atresia de coanas; nasofibroscopia
- D)** Laringomalacia; laringoscopia directa
- E)** Desviación septal congénita; TAC de senos paranasales

RESUMEN: RESPIRADOR BUCAL

El respirador bucal es un motivo de consulta frecuente en pediatría y otorrinolaringología. La primera distinción importante es entre el falso respirador bucal (persona que tiene la boca abierta pero respira por la nariz) y el verdadero respirador bucal (que efectivamente respira por la boca). La diferenciación se realiza verificando por dónde pasa el aire. El verdadero respirador bucal se subdivide en obstructivo y no obstructivo. El obstructivo respira por la boca porque tiene la nariz tapada y no puede respirar nasalmente. El no obstructivo puede respirar por la nariz si se le pide cerrar la boca, pero por hábito o hiperlaxitud respira por la boca. Las causas del tipo obstructivo son: rinitis alérgica (la más frecuente), hipertrofia de adenoides, tumores nasosinusales, entre otras. El no obstructivo se debe a hiperlaxitud o mal hábito. El estudio del respirador bucal verdadero y obstructivo se realiza con radiografía de cavum para evaluar hipertrofia de adenoides. El tratamiento depende de la causa: si es hipertrofia de adenoides aislada, se realiza adenoidectomía; si es rinitis alérgica, se inician corticoides nasales (tratamiento de elección para rinitis alérgica con obstrucción), a diferencia de los antihistamínicos que se usan cuando no hay obstrucción. Si coexisten ambas patologías, siempre se trata primero la rinitis alérgica por ser menos invasiva. En recién nacidos con respiración bucal desde el nacimiento, se debe descartar atresia de coanas mediante nasofibroscofia, con eventual corrección quirúrgica.